

CHAPTER 03

模擬考卷・詳解版

Mock Exam • Answer Key

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

病理科模擬考卷詳解版 (最新兩次考題 50 題)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生・答案以官方為準;機轉與教學延伸為 AI 整理,可能有誤,請對照 Robbins / WHO 查證

答案逐題詳解 + 機轉解釋 + 教學重點 + 干擾選項拆解。建議教學時逐題帶過。

答案總覽

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
Q1	D	Q11	A	Q21	A	Q31	A	Q41	B
Q2	A	Q12	B	Q22	A	Q32	D	Q42	D
Q3	D	Q13	C	Q23	B	Q33	A	Q43	D
Q4	B	Q14	C	Q24	D	Q34	C	Q44	B
Q5	C	Q15	D	Q25	A	Q35	D	Q45	B
Q6	A	Q16	B	Q26	B	Q36	D	Q46	B
Q7	A	Q17	A	Q27	A	Q37	A	Q47	A
Q8	C	Q18	C	Q28	A	Q38	B	Q48	A
Q9	C	Q19	A	Q29	C	Q39	D	Q49	A
Q10	D	Q20	A	Q30	C	Q40	D	Q50	C

Q11(鼻咽癌題)官方答案為「#」(送分題),但學理上 A 是錯誤敘述(鼻咽癌與 **EBV** 相關,非 HPV)。

Part 1 — 114 年第 2 次詳解

Q1(答 D) coagulative necrosis 顯微特徵

- **核心知識:**凝固性壞死 = 細胞質強烈嗜酸性紅染、核淡化或消失(karyolysis),但細胞結構輪廓 ghost-like 仍可辨認
- **干擾選項拆解:**

- (A) 液化性壞死 → 腦梗塞、化膿，整片融解
- (B) 乾酪性壞死 → 結核中央，似 cheese 碎屑，無細胞結構
- (C) 纖維素樣壞死 → 血管壁，PAS+ 強嗜酸帶
- **教學延伸**：心肌梗塞為典型 coagulative；脾、腎、心、肝 ischemic infarct 皆為 coagulative

Q2 (答 A) 不可逆細胞傷害標誌

- **核心知識**：粒線體膜通透性轉換孔(mPTP)開啟 → 粒線體蛋白(cytochrome c)外漏 = **不可逆 point of no return**
- **干擾選項**：(B)(C)(D) 都是「可逆」傷害的早期變化
- **教學延伸**：可逆 vs 不可逆的三大分水嶺：① 嚴重粒線體破壞 ② 細胞膜廣泛缺損 ③ DNA 與核蛋白溶解
- **臨床應用**：troponin 升高 = 心肌已進入不可逆，因為它是粒線體釋出物

Q3 (答 D) Marfan syndrome

- **核心知識**：**Fibrillin-1 (FBN1)** 突變，**體染色體顯性**遺傳，**身材高瘦**(非矮小)，主動脈根部擴大 → 主動脈剝離
- **錯誤選項解構**：
 - (A) 不是 collagen → 是 **fibrillin-1**(彈性蛋白支架)
 - (B) 不是隱性 → 是顯性
 - (C) 不是矮小 → 是高瘦、長指
- **重要對比**：Ehlers-Danlos = collagen 異常，Osteogenesis imperfecta = collagen I 異常
- **教學重點**：「主動脈剝離 + 高瘦」= Marfan

Q4 (答 B) Pemphigus vulgaris

- **核心知識**：抗 desmoglein 3/1 IgG → **Type II 過敏反應**(抗體對抗細胞表面抗原)
- **DIF 影像**：表皮內**網狀魚網樣**(fish-net)沉積
- **臨床特徵**：脆弱性鬆弛大水皰、Nikolsky sign 陽性
- **對比**：Bullous pemphigoid → anti-BP180/230，基底膜帶**線狀**沉積，仍屬 Type II 但水皰較紮實
- **治療**：類固醇 + **Rituximab**(抗 CD20)

Q5 (答 C) 慢性 CO 中毒

- **核心知識**：慢性低劑量 CO → **basal ganglia**(特別是 globus pallidus)對缺氧最敏感 → 雙側對稱性壞死
- **急性高劑量 CO**：cherry red 皮膚顏色 + 廣泛大腦皮質損傷
- **延伸**：缺氧最易壞死的部位序列 = 海馬 CA1 (pyramidal) > Purkinje 細胞 > 大腦第 3、5、6 層皮質 > basal ganglia

Q6 (答 A) 惡性腫瘤最不可靠特徵

- **核心知識**：**生長快速**不可靠 — 良性也可能快速生長(如妊娠中乳腺纖維腺瘤)；惡性也可能緩慢
- **最可靠 = (D) 轉移**(pathognomonic for malignancy)
- **教學重點**：四大可靠惡性特徵 = ① 轉移 ② 侵犯 ③ 嚴重 atypia + 異常 mitosis ④ 失分化

Q7 (答 A) 先天性心臟病與肺高壓

- **核心知識**: 左向右分流 (VSD、ASD、PDA) → 肺血流增加 → 久了肺血管阻塞性病變 → 肺高壓 → **Eisenmenger** 反轉
- **干擾選項**:
 - (B) Fallot 是右向左 → 肺血流**減少**, 無肺高壓
 - (C) Coarctation → 上肢高血壓不是肺高壓
 - (D) Isolated PS → 右心室代償, 肺壓不升
- **教學延伸**: 肺血管病變六階段 (Heath-Edwards classification)

Q8 (答 C) 非血小板缺陷的凝血異常

- **核心知識**:
 - (A) vWD → vWF 缺, 影響血小板黏附 (**也**算血小板功能)
 - (B) 尿毒症 → 血小板功能異常
 - (D) Aspirin → 抑制 COX → 血小板功能異常
 - **(C) Hemophilia = Factor VIII/IX 缺失 (凝固因子, 非血小板)**
- **教學延伸**: BT vs aPTT 鑑別出血傾向
 - BT 延長 = 血小板異常或 vWD
 - aPTT 延長 = 內生路徑 (Hemophilia)
 - PT 延長 = 外生路徑 (VII 缺、warfarin)

Q9 (答 C) Hodgkin lymphoma 腫瘤細胞稀少

- **核心知識**: Hodgkin lymphoma 中真正的腫瘤細胞 **Reed-Sternberg 細胞** 只佔少數 (< 5%), 其餘為反應性發炎細胞 (lymphocyte、eosinophil、plasma cell、neutrophil)
- **RS 細胞**: CD15+、CD30+、CD45-、PAX5 弱+, 雙葉核「貓頭鷹眼」
- **對比**: DLBCL、Burkitt、ALCL 腫瘤細胞 = 主體

Q10 (答 D) 骨髓造血細胞最少

- **核心知識**: **Aplastic anemia** = 骨髓**空蕩**、被脂肪取代
- **其他三者**骨髓 cellular ↑:
 - IDA → erythroid hyperplasia
 - Megaloblastic → 巨母紅血球性 hyperplasia
 - Thalassemia → 嚴重 erythroid hyperplasia (骨髓擴張 → crew-cut skull)

Q11 (答 A, 官方送分) 鼻咽癌

- **學理正確答案 = A**: 鼻咽癌與 **EBV** 相關, 非 HPV
- 但因爭議性 (南方型 keratinizing 偶爾與 HPV 相關), 官方判送分
- **教學重點**: 鼻咽癌「三大特徵」= ① EBV ② 南亞/南中國高發 ③ 頸部淋巴結轉移先表現
- **染色**: EBER ISH 是診斷標配

Q12(答 B)小細胞肺癌錯誤敘述

- **核心知識**: SCLC 幾乎不帶 EGFR 突變(EGFR 是**腺癌**亞洲女性非吸菸者的特徵)
- SCLC 分子特徵 = **TP53 + RB** 雙失活(>90%)
- SCLC 副腫瘤: SIADH、Cushing(ACTH 分泌)、Lambert-Eaton

Q13(答 C)矽肺病錯誤敘述

- **核心知識**: 矽肺病肺纖維化**不可逆**, 停止暴露後**不會恢復**, 嚴重者需肺移植
- 矽肺三大特徵: ① 上肺葉 nodule ② whorled collagen ③ 偏光下 birefringent silica 粒
- **重要併發症**: 矽肺 → 結核**易感**(silicotuberculosis)

Q14(答 C)口腔癌錯誤敘述

- **核心知識**: 口腔 SCC 雖有 TP53/CDKN2A/PIK3CA 突變, **但目前並無有效靶向藥**(這些都是 tumor suppressor、難以針對)
- 治療仍以手術 + 放化療為主, 免疫療法(pembrolizumab)為近年新增
- **教學重點**: 頭頸 SCC 與肺腺癌「分子相似但治療路徑不同」

Q15(答 D) HNF1α-inactivated HCA

- **核心知識**: HNF1α 失活 → **LFABP 表現喪失**(題目反過來說 = 錯)
- HCA 四大分子分型(重要!):

分型	標記	風險
HNF1α inactivated	LFABP 失	極低惡變
Inflammatory	SAA、CRP+	中等惡變
β-catenin activated	nuclear β-catenin、GS 瀰漫+	高 惡變
Unclassified	—	不定

- **臨床**: MODY-3 患者多型; 好發於女性(口服避孕藥相關)

Q16(答 B)急性膽囊炎錯誤敘述

- **正確機轉**: 阻塞 → 黏膜傷害 → 釋出**前列腺素** → 發炎(題目說「減少」是錯的)
- 90% 結石性, 10% 非結石性(與敗血症、創傷、TPN、缺血有關)
- **教學延伸**: 膽石症 5F = Female、Fat、Forty、Fertile、Fair

Q17(答 A) Renal oncocytoma

- **核心知識**: 胞質充滿**粒線體** → 嗜酸性
- **形態**: mahogany brown 顏色(肉眼)、central scar(影像)、neoplasm cell 巢狀
- **重要鑑別**: vs Chromophobe RCC(也嗜酸)

- Oncocytoma 是**良性**
- Chromophobe RCC 含 microvesicle (PAS+)，plant-cell-like 細胞膜

Q18(答 C) Xanthogranulomatous pyelonephritis

- **核心知識**: **Proteus mirabilis** (urea splitting → struvite stone → 反覆感染)
- 形態: 黃色泡沫巨噬細胞 (lipid-laden macrophages) 瀰漫
- 臨床: 女性多、結石、糖尿病
- **腫瘤偽裝**: 常被誤以為 RCC (術前難鑑別)

Q19(答 A) 腎細胞癌最大危險因子

- **核心知識**: **抽菸** 是首位 (其次 HTN、肥胖、慢性腎病、VHL)
- 石綿 → mesothelioma、肺癌 (非 RCC)
- 教學延伸: clear cell RCC 與 **VHL** 基因 3p25 缺失相關

Q20(答 A) 放射線治療後乳房肉瘤

- **核心知識**: 放射後最常見的二次惡性 = **angiosarcoma** (潛伏期 5-10 年)
- 表現: 紫紅斑塊、結節
- **IHC**: CD31、CD34、ERG (內皮標記) +

Q21(答 A) 乳房 ALH 風險

- **核心知識**: Atypical lobular hyperplasia → 雙側乳癌風險 × **4-5 倍**
- 比 sclerosing adenosis、complex sclerosing lesion 高
- **臨床處置**: 診斷後密切追蹤 + 考慮 tamoxifen 預防

Q22(答 A) 子宮頸 HSIL

- **核心知識**: 基底層 2/3 以上 atypia = HSIL (CIN II-III)
- 對比: LSIL = 下 1/3 + koilocyte (HPV cytopathic effect)
- **進展風險**: HSIL → invasive Ca 約 30%

Q23(答 B) 蝕骨細胞活性異常

- **核心知識**:
 - ① Osteopetrosis = osteoclast **不能** resorb (mutation in CA II 等)
 - ③ Post-menopausal osteoporosis = 雌激素 ↓ → osteoclast **過度活化**
 - ⑤ Paget disease = osteoclast **異常巨大過度活化** + osteoblast 失調
 - ② Senile osteoporosis = osteoblast 老化 → 屬 osteoblast 問題
 - ④ Osteomalacia = vitamin D 缺乏 → 骨基質礦化不足，與 osteoclast 無關

Q24(答 D) 皮膚培養出致病菌

- **核心知識**: Erythema migrans = Lyme disease, **Borrelia burgdorferi** 可在病灶處培養

- 其他 erythema 多為免疫反應性(無活菌):
 - EM → drug、HSV 反應
 - Erythema induratum → 結核反應(panniculitis)
 - Erythema nodosum → 結核、Strep、藥物、IBD 反應

Q25(答 A) 感染性關節炎錯誤敘述

- **核心知識**: 兩歲以下幼兒最常見化膿性關節炎 = **Staphylococcus aureus**
 - Salmonella 在**鎌形細胞病**患者特別好發(不是 default)
- 年齡分層:
 - 新生兒: S. aureus、GBS、Gram(-) bacilli
 - < 2 歲: S. aureus、H. influenzae(疫苗後減少)
 - 青少年: **Neisseria gonorrhoeae**
 - 成人: S. aureus

Part 2 — 115 年第 1 次詳解

Q26(答 B) Phosphatidylserine 外翻

- **核心知識**: 細胞凋亡早期, **flippase 失活** → PS 從內層翻到外層 → "eat me" 信號 → 巨噬細胞吞噬
- **臨床應用**: Annexin V 染色(PS-binding) = 早期凋亡偵測
- **延伸**: 對比細胞凋亡 vs 壞死的吞噬機制(凋亡無發炎; 壞死有發炎)

Q27(答 A) 生理性肥大主要路徑

- **核心知識**: **PI3K/AKT/mTOR** = 生理性肥大(運動員心臟、孕婦子宮)
- 對比病理性肥大(壓力負荷高血壓心臟) = **GPCR 活化、Ca⁺⁺/calcineurin/NFAT**
- 延伸: PIK3CA 突變 → 腫瘤性 PI3K 過度活化 → Alpelisib 為標靶

Q28(答 A) 病毒-疾病錯誤配對

- **正確**: Hairy leukoplakia = **EBV**(HIV 患者)
- HPV → 條狀疣、口腔 papilloma、SCC
- 其他三個都正確: HHV-8/PEL、EBV/NK-T、JCV/PML
- **教學重點**: 免疫缺陷者「病毒-腫瘤」清單

Q29(答 C) 腎臟移植排斥分類

- **核心知識**:

排斥類型	時程	主要病理	治療
Hyperacute	分鐘-小時	預存抗體 → 血栓	切除腎臟

排斥類型	時程	主要病理	治療
Acute cellular	天-週	淋巴細胞浸潤 tubulitis/vasculitis, C4d 陰性	高劑量類固醇、ATG
Acute antibody-mediated	天-週	DSA、C4d 陽性、microvasc 炎	血漿置換、IVIG、Rituximab
Chronic	月-年	間質纖維化、tubular atrophy、血管硬化	難治

- 本題：淋巴浸潤 + C4d 陰性 = **Acute cellular**

Q30(答 C) Pellagra

- **核心知識**：Niacin (B3) 缺乏 → **3D**：
 - Dermatitis(光照部位粗糙、casal necklace)
 - Diarrhea
 - Dementia
- **常見族群**：玉米為主食地區(玉米中 niacin 為結合型不易吸收)、酗酒、Carcinoid syndrome(色胺酸被轉作 serotonin)

Q31(答 A) MI 3 小時肉眼變化

- **核心知識**：MI 病理時間軸

時間	肉眼	顯微
0-4h	無變化	無變化(電顯可見)
4-12h	黑暗色	early coagulative necrosis、wavy fiber
12-24h	大理石樣	完整 coagulative necrosis、early PMN
1-3d	黃色軟化(中央)	PMN 浸潤
3-7d	中央黃褐、邊緣紅褐	Macrophage 清除
1-2w	凹陷紅灰色	肉芽組織
> 2w	灰白堅硬瘢痕	膠原沉積

- 3 小時 → 答案 (A) 看不出變化(顯微才能看到 early changes)

Q32(答 D) CHF 水腫機轉

- **核心知識**：水腫 4 大機轉

機轉	例子
↑ 靜水壓	CHF、深部靜脈栓塞
↓ 滲透壓 (osmotic)	肝硬化、腎病、營養不良
淋巴阻塞	乳癌術後、絲蟲
↑ 通透性	發炎、過敏

- CHF 主要機轉是**靜水壓**升高，不是滲透壓下降

Q33(答 A) Giant cell arteritis

- 核心知識**: GCA = 老年人(> 50 歲，常 > 70)、**大中血管**、**頭部**為主(顳動脈、眼動脈)
- 病理:**granulomatous** + 多核巨細胞 + IEL 斷裂
- 併發症:**失明**(眼動脈分支阻塞，**急症**需立即類固醇)
- 對比：
 - Polyarteritis nodosa → 中血管、腎/腸繫膜
 - Takayasu → 大血管、**主動脈弓**、年輕女性
 - Kawasaki → 小孩、冠狀動脈瘤

Q34(答 C) IDA 實驗值

- 核心知識**: IDA 五大實驗值

項目	變化
Hct、Hb	↓
MCV	↓ (microcytic)
MCHC	↓ (hypochromic)
Serum iron	↓
TIBC	↑
Ferritin	↓
轉鐵蛋白飽和度	↓

- 對比 anemia of chronic disease: Ferritin ↑、TIBC ↓

Q35(答 D) G6PD 缺乏症

- 核心知識**: **X-linked recessive**(男性多)
- 病生: 缺 G6PD → NADPH ↓ → glutathione 不能還原 → 紅血球抗氧化能力 ↓

- 誘發: fava beans、antimalarials、sulfa 藥
- 鏡下: **Heinz body**、**bite cell**

Q36(答 D) Celiac disease

- **核心知識**: Celiac disease 相關淋巴瘤 = **Enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL)**, 非 B 細胞
- 其他重點: HLA-DQ2/DQ8、上皮內淋巴球 ↑、絨毛萎縮、隱窩增生
- **抗體**: Anti-tissue transglutaminase (tTG)、anti-endomysial
- **治療**: 終身無麩質飲食

Q37(答 A) HGSC 基因突變

- **核心知識**: High-grade serous ovarian Ca = **TP53 突變 > 96%**
- 衍生: BRCA1/2 mutation 是另一重要群 (占 20%)
- 形態: psammoma body、SET pattern、輸卵管 fimbrial origin (STIC)
- **治療意義**: BRCA+ 適用 PARP inhibitor

Q38(答 B) MSA α-synuclein

- **核心知識**: MSA = α-syn 包涵體位於 **oligodendrocyte** (GCI = glial cytoplasmic inclusion)
- **重要對比**:

疾病	α-syn 包涵體位置
PD、DLB	神經元 (Lewy body)
MSA	Oligodendrocyte (GCI)

- 臨床: MSA = parkinsonism + autonomic dysfunction + cerebellar ataxia 混合

Q39(答 D) RA 與 TNF

- **核心知識**: **TNF-α** 是 RA pannus 形成的關鍵 cytokine
- 拮抗劑: Infliximab、Etanercept、Adalimumab
- 其他 RA 治療靶點:
 - IL-6 → Tocilizumab
 - CTLA4-Ig → Abatacept
 - CD20 → Rituximab
 - JAK → Tofacitinib

Q40(答 D) Pulmonary HTN 錯誤敘述

- **核心知識**: **Plexiform lesion** = **晚期** PAH 病理特徵 (不是早期)
- 早期: medial hypertrophy、intimal proliferation

- 中期:concentric intimal fibrosis
- 晚期:**plexiform lesion**、necrotizing arteritis
- WHO 分類 PAH 5 群:(1) 特發/遺傳/藥物 (2) 左心病變 (3) 肺病/缺氧 (4) PE (5) 多因素

Q41(答 B)大葉性肺炎分期

- **正確順序:congestion → red hepatization → gray hepatization → resolution**
 - Congestion:充血、漿液性滲出
 - Red hepatization:RBC + neutrophil + fibrin 滿肺泡
 - Gray hepatization:RBC 溶解、PMN 持續、fibrin 為主
 - Resolution:吞噬清除、結構恢復
- 題目把 gray 和 red 順序顛倒 = 錯
- **常見病原**:S. pneumoniae(大葉性)vs S. aureus/H. influenzae/Mycoplasma(支氣管性)

Q42(答 D)支氣管擴張症症狀

- **核心知識**:支擴常見 = 慢性咳嗽 + 大量膿痰 + 咳血 + 杵狀指
- **過度換氣**(hyperventilation)是焦慮症狀,非典型支擴症狀
- 病因:CF、Kartagener、結核、ABPA、麻疹/百日咳後遺、IgG/IgA 缺乏

Q43(答 D)自體免疫肝炎

- **核心知識**:自免肝炎血清 = **IgG ↑** (不是 IgM)
- IgM 升高 → primary biliary cholangitis (PBC)
- AIH 分型:
 - Type 1:ANA、ASMA → 成人女性、HLA-DR3/DR4
 - Type 2:LKM-1、LC1 → 兒童
- 治療:類固醇 ± azathioprine

Q44(答 B)UC 錯誤敘述

- **核心知識**:UC = **僅累及結腸與直腸**(不包括 ileum);發炎僅限**黏膜層**
- "backwash ileitis"(嚴重 UC 偶爾累及末端 ileum) ≠ "涉及 ileum"
- **重要對比 UC vs Crohn**:

特徵	UC	Crohn
位置	結腸 + 直腸	末端迴腸最常見,任何處
連續性	連續	skip lesion
深度	mucosa	transmural
肉芽腫	無	有 (30%)
假息肉	常見	罕見

特徵	UC	Crohn
瘻管	罕見	常見
結腸 Ca 風險	↑ ↑	↑
p-ANCA / ASCA	p-ANCA+	ASCA+

Q45 (答 B) ACTH-independent Cushing

- **核心知識**:
 - ACTH-dependent (80%): 垂體腺瘤 (Cushing disease)、ectopic ACTH (SCLC、carcinoid)
 - ACTH-independent (20%): **腎上腺腺瘤** > 增生 > 腺癌
- **診斷流程**: 24h cortisol → ACTH 測定 → MRI/CT
- 形態: 腎上腺單側腫大 (腺瘤) vs 雙側 (hyperplasia)

Q46 (答 B) FSGS

- **核心知識**: 原發性 FSGS 從 **juxtamedullary** 腎絲球先病變
- 兒童腎病症候群最常見 = **Minimal change disease** (不是 FSGS; 成人 FSGS 較常見)
- 類固醇反應: FSGS **不佳** (Minimal change 反應極佳)
- EM: 足細胞 foot process 廣泛融合 (類似 MCD) + 節段性硬化、玻璃樣變

Q47 (答 A) 橋本氏甲狀腺炎

- **核心知識**: anti-TPO + anti-thyroglobulin (≥ 90% 患者陽性)
- **病理**: lymphocyte 浸潤、germinal center、**Hürthle cell** (eosinophilic 變性的甲狀腺濾泡細胞)
- 臨床: 起初可能短暫 thyrotoxicosis → 後期 hypothyroidism
- 併發: MALT lymphoma 風險 ↑

Q48 (答 A) Papillary DCIS vs Papilloma

- **核心知識**: 兩者都有 papilla, 但 papilloma **保有肌上皮**, DCIS **無肌上皮**
- IHC: p63、SMA、calponin → 標記肌上皮
- 教學重點: 「有 **myoepithelium** = 良性」是乳房病理鐵則

Q49 (答 A) 侵犯性乳癌 ER/PR/HER2 組合

- **核心知識**: 四大分子分型

分型	比例	治療
Luminal A : ER+/PR+/HER2- (Ki67 低)	最多 ~50%	內分泌治療為主
Luminal B: ER+/PR+/HER2± (Ki67 高)	~15-20%	內分泌 + 化療 ± HER2 標靶
HER2-enriched: ER-/PR-/HER2+	~10-15%	Trastuzumab 等 HER2 標靶

分型	比例	治療
Triple negative:ER-/PR-/HER2-	~15-20%	化療為主、近年免疫療法

Q50 (答 C) Duret hemorrhage

- **核心知識**: Duret hemorrhage = transtentorial (uncal) herniation → 下行性壓迫 brainstem → **midbrain/pons 中央線性出血**
- 其他疝出：
 - Subfalcine (cingulate): 扣帶迴在大腦鎌下，可能壓 ACA
 - Transtentorial (uncal): 顳葉鉤回，壓 CN III、PCA、brainstem (**Duret**)
 - Tonsillar: 小腦扁桃體 → foramen magnum，壓延髓 → 呼吸停止

計分與分析建議

分數	評估	建議行動
≥ 80 分 (≥ 40 對)	卓越	加強冷門考點 + WHO 新版分類
70-79 分 (35-39 對)	達標	補強錯題系統 + 多做 buzzword 認知
60-69 分 (30-34 對)	勉強過關	系統性回看五大系統高頻疾病
50-59 分 (25-29 對)	不及格	從基礎重新建構 (Robbins 9 大章節)
< 50 分	嚴重不足	重新從基本病理學概念開始

錯題分類本範本

題號	系統	主題	錯誤類型	對應教材章節
Qx	(系統)	(疾病)	概念錯/粗心/沒看過	Robbins Ch X